Sobre la calidad de los documentos entregados

Historia clínica de una paciente · portal GVA Salut

Solicitud de acceso — art. 15 RGPD · Solicitud de portabilidad — art. 20 RGPD

De qué se trata

Descargué del portal la historia clínica completa de mi esposa: **59 documentos**, todos en PDF.

No es una queja sobre el contenido médico, que no discuto. Es una constatación sobre **la forma en que se entregan los datos** — y sobre lo que, entregados así,
resulta imposible hacer con ellos.

Cada documento fue leído uno por uno. Lo que sigue no es una impresión: son recuentos, con los nombres de los ficheros.

Los documentos

Tipo	Cantidad
Informes de Urgencias (`ICU`)	17
Informes de Prueba diagnóstica (`PRI`)	14
Informes de resultados de Pruebas (`PRL`)	8
Informes de Alta (`ICA`)	5
Informes de Continuidad de Cuidado (`ICC`)	4
Historia Clínica Resumida (`HCR`)	4
Otros (`RPE`)	2
Total leído	**54**

Lo que falta, documento por documento

1 · La fecha de la extracción no está impresa

23 documentos afectados

En estos documentos figuran resultados de analítica, pero **no el día en que se tomó la muestra**. Sólo consta la fecha del episodio, o la de la firma.

Un resultado sin fecha de toma no se puede situar en el tiempo. Para un seguimiento de diez años — que es exactamente lo que necesita quien cuida a una persona mayor — una serie de valores sin fechas fiables no dice nada.

Ficheros: `HCR_17072026045212.pdf` · `HCR_17072026065532.pdf` · `ICA_11072026074246.pdf` · `ICA_17072026052307.pdf` · `ICA_17072026070616.pdf` · `ICA_17072026070705.pdf` …

2 · Fechas incompletas: sólo el año, o el mes

12 documentos afectados

Antecedentes fechados «2016», «septiembre 2021», «2023». Sin día.

Entiendo que un antecedente antiguo pueda no tener día exacto. Pero cuando se trata de un ictus o de una trombosis, el día importa: es lo que permite saber qué tratamiento se dio antes y cuál después.

Ficheros: `ICA_11072026074246.pdf` · `ICA_17072026070705.pdf` ·

`ICU_17072026052105.pdf` · `ICU_17072026052127.pdf` · `ICU_17072026052202.pdf` · `ICU_17072026052229.pdf` …

3 · Fecha de firma posterior a los hechos

10 documentos afectados

Once documentos llevan **fecha de firma de julio de 2026** para episodios ocurridos en 2025 o antes — un año después.

Un informe no puede firmarse un año después del alta. O bien el campo «firma» recoge en realidad la fecha de impresión, o bien hay un error sistemático.

En cualquiera de los dos casos: **el documento entregado no permite saber cuándo fue redactado**. Y ese dato no es accesorio — es lo que da valor legal a un informe clínico.

Ficheros: `ICA_17072026070742.pdf` · `ICU_11072026074210.pdf` · `ICU_17072026051946.pdf` · `ICU_17072026052018.pdf` · `ICU_17072026052105.pdf` · `ICU_17072026052127.pdf` …

4 · Sin número de informe ni de solicitud

11 documentos afectados

Ningún identificador que permita referirse a un documento concreto: ni número de informe, ni número de solicitud de laboratorio.

Sin ellos, **no se puede citar un documento**. Ni pedir una corrección sobre él, ni señalar un error, ni comprobar si dos documentos son el mismo.

Ficheros: `HCR_17072026065532.pdf` · `ICA_17072026070742.pdf` · `ICC_17072026070516.pdf` · `ICU_17072026052018.pdf` · `ICU_17072026052105.pdf` · `ICU_17072026052229.pdf` …

5 · Gasometrías sin su condición de medida

4 documentos afectados

Valores de gasometría sin indicar la FiO2 ni si la paciente respiraba aire ambiente u oxígeno.

Una pO2 bajo oxígeno y una pO2 al aire **no se comparan**. Sin la condición, el valor no significa nada, y ponerlos en la misma serie es peor que no tenerlos: da una curva que miente.

Ficheros: `ICA_17072026052307.pdf` · `ICA_17072026070616.pdf` · `ICA_17072026070742.pdf` · `ICU_17072026070137.pdf`

6 · Valores citados en texto, sin cifras

2 documentos afectados

Resultados mencionados de forma narrativa — «insuficiencia respiratoria parcial crónica» — sin los valores numéricos que los sustentan. O parámetros marcados con asteriscos en lugar de la cifra.

Ficheros: `ICU_17072026052018.pdf` · `ICU_17072026052105.pdf`

Documentos repetidos, imposibles de distinguir

El portal entrega el mismo informe tantas veces como se descarga. El nombre del

fichero cambia — pero **sólo por el segundo de impresión**:

```
ICU_17072026052018.pdf
ICU_17072026052045.pdf     ¿el mismo documento? nada lo dice
ICU_17072026052105.pdf
```

Como los documentos tampoco llevan número de informe (punto 4), **no hay manera de saber si dos ficheros son el mismo documento** sin abrirlos y compararlos línea por línea.

Lo que pido

El artículo 20 del RGPD habla de un formato **«estructurado, de uso común y lectura mecánica»**. Lo que se me ha entregado son impresiones en PDF: hechas para el ojo, no para ser leídas por una máquina.

Solicito, por tanto:

1. **Los mismos datos en formato estructurado** — JSON, XML, CSV o HL7 FHIR, cualquiera de uso común. No una impresión de ellos.

2. **Que cada documento lleve su identificador**: número de informe o de episodio, de modo que se pueda citar, corregir y comprobar.

3. **Que las fechas sean las de los hechos**: fecha de toma para una analítica, fecha real de redacción para un informe. No la del día en que se imprimió.

4. **Que las mediciones lleven sus condiciones** cuando sin ellas no significan nada — la FiO2 de una gasometría, por ejemplo.

Por qué esto importa

No pido esto por curiosidad técnica.

Mi esposa tiene 88 años y una demencia avanzada. La cuido en casa. En diez años ha pasado por varios hospitales y varios servicios, y **ninguno tiene la lista completa de lo que toma**. Yo sí — o podría tenerla, si los datos que me entregan fueran utilizables.

Reunir esa historia dispersa es exactamente lo que el artículo 20 pretende permitir. Un PDF de impresión lo impide.

Este documento se apoya en un registro de lectura generado automáticamente el 9 de septiembre de 2026, disponible si se solicita. Recoge, documento por documento, lo que faltaba en cada uno.